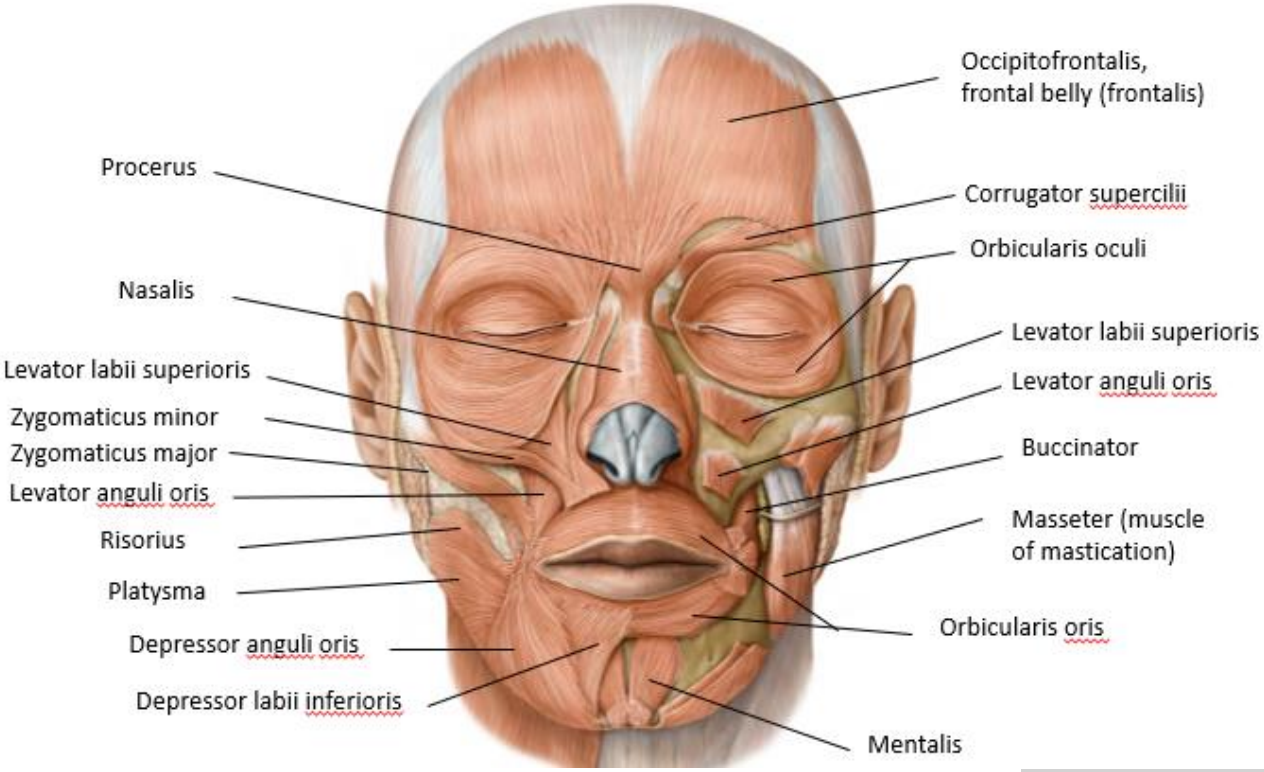
بسمه تعالی

ناحیه صورت:



شکل (۱) عضلات صورت

ناحیه صورت ناحیه ایست که در پایین محدود می شود به خطی که این خط از symphis menti شروع و در امتداد کنار تحتانی فک تا زاویه فک و از زاویه فک تا زائده ماستوئید و از آنجا از طریق خط پس سری فوقانی به برجستگی پس سری بیرونی می رسد.حد فوقانی صورت خطی است که در جلو از قوسهای ابرویی شروع و ادامه آن از انتهای خارجی قوس ابرویی به برجستگی پس سری بیرونی استخوان پس سری کشیده می شود. این خط در واقع ناحیه صورت را از اسکالپ جدا می کند.

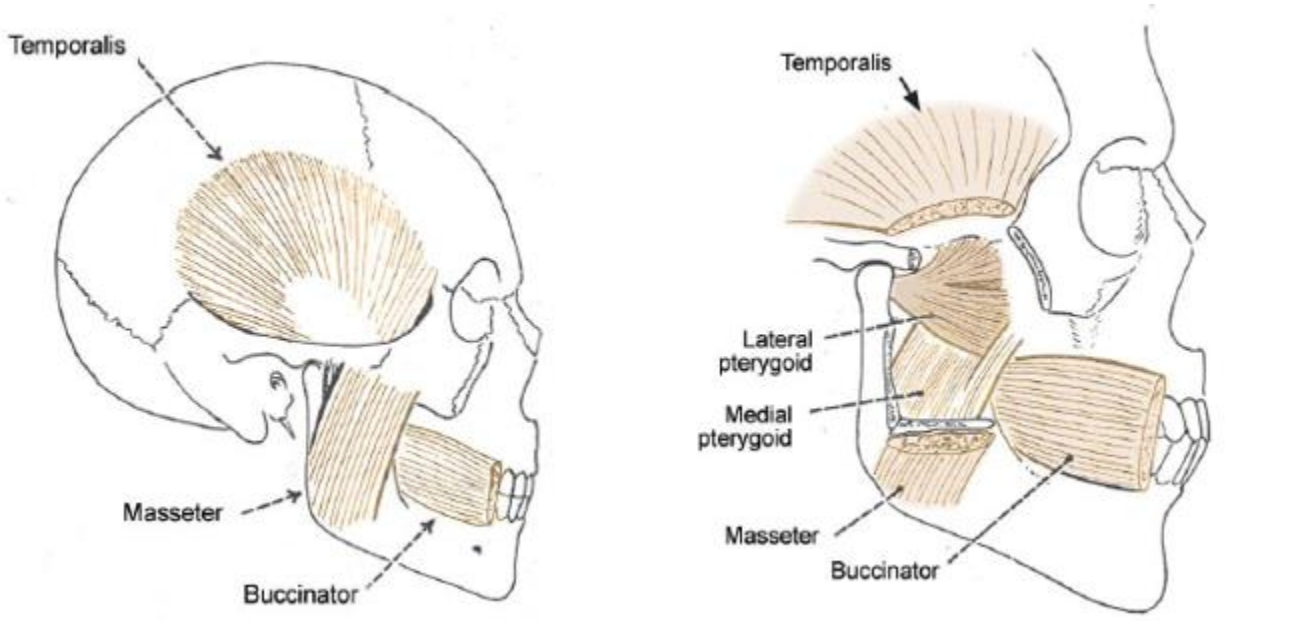
عضلات ناحیه صورت عضلات ناحیه صورت را بدو دسته تقسیم می کنند:

superficial یا سطحی:

عضلاتی هستند که یک سر آنها به استخوانهای صورت متصل و یک سر دیگر آنها به پوست صورت در نواحی مختلف متصل شده است. انقباض این عضلات سطحی حالاتی را مثل تبسم اخم و حالات شاد و اندوه در صورت ایجاد کرده بنابراین در کل موجب تغییر حالت صورت می شوند بنابراین به این عضلات عضلات حالت دهنده صورت یا muscle of expressionگفته می شود این عضلات چون از کمان دوم برونشیال منشا می گیرند بنابراین تماما توسط شاخه های عصب Facial عصب دهی می شوند .

deep -یا عمقی:

عضلات عمقی تمام عضلات جوینده یا muscle of mastigation که در عمل جویدن نقش دارند توسط شاخه حرکتی عصب مندیبولار شاخه ای از عصب سه قلو است تغذیه می کند. این عضلات از کمان دوم حلقی مشتق می شوند. شکل (۲)



شکل (۲) عضلات عمقی صورت

عضلات سطحی: در سه ناحیه متمرکز و عبارتند از:

۱) عضلات اطراف چشم شامل عضله مدور چشم یا orbicularis occuli و عضله درهم کشنده ابرو یا corrugator supercilliمی باشند.

۲) عضلات اطراف بینی شامل nasalis-procerous باعضله دقت یا عضله بینی

و depressor septi یا پایین آورنده سپتوم بینی است.

۳)عضلات اطراف دهان که این عضلات شامل aorbicularis oris :یا عضله دور دهان

Levator Labi superior بالا برنده لب بالا و Levator Anguli oris یا بالا برنده گوشه دهان

Levator Labi superior and Aequenasi یا عضله بالا برنده لب بالا و کشنده پره بینی

Zygo-matic Major and Minorیا گونه ای بزرگ و کوچک

Depressor anguli oris یا پایین آورنده گوشه دهان

Depressor Labi inferior یا پایین آورنده لب پایین mentalils یا عضله چانه ای

Risorius یا عضله خندان

Buccinator یا عضله شیپوری می باشند.

• Orbicularis occuli

این عضله دارای سه بخش Orbital یا کاسه چشمی پلکی یا palpebral و اشکی یا Lacrimal است شکل (۱).

بخش orbital آن در گوشه داخلی چشم از زائده بینی استخوان پیشانی شروع شده و پس از دورزدن محیط قاعده اربیت به زائده پیشانی استخوان ماگزیلا ختم می شود.

-بخش پلکی آن از رابط پلکی داخلی شروع و در سمت خارج به رباط پلکی خارجی اتصال پیدا می کند. (رباط پلکی داخلی پلک را به ستیغ اشکی قدامی و رباط پلکی خارجی پلک را در خارج به استخوان گونه وصل می کند)

بخش اشکی یا Lacrimal آن از ستیغ اشکی خلفی شروع شده و به جدار خارجی کیسه اشک می چسبد. عضله مدور چشم در برابر نور خورشید چشم را محافظت کرده و بخش اشکی آن موجب وارد شدن اشک بداخل کیسه اشک شده تا از طریق مجرای nasolacrimalبه مناتوس تحتانی تخلیه شود. این عضله از شاخه گیجگاهی و گونه ای عصب فاسیال عصب می گیرد.

● Corrugators supercilli

این عضله از قسمت داخلی قوس ابرویی شروع شده و به پوست نیمه داخلی ابرو اتصال پیدا می کند. شکل (۱).

این عضله موجب چنین در ابرو می شود. عصب این عضله از شاخه گیجگاهی عصب Facial است.

● Nazalis

این عضله دارای دو بخش Transverse و Alar است بخش transverse آن از برآمدگی canine فک بالا شروع شده و در روی بینی با transverse سمت مقابل مخلوط می شود. بخش Alar عضله از برآمدگی Insisive lateral شروع شده و به غضروف پره بینی اتصال پیدا می کند شکل (۱).. عضله nasalis توسط شاخه Buccal عصب فاسیال تغذیه می شود.

● Depressor septi

از برجستگی Incisive میانی شروع شده و ستپوم بینی می چسبد و عمل آن این است که ستپوم بینی را به سمت پایین می کشد. عصب آن از عصب Buccal فاسیال است.

Procerous یا عضله دقت:

از ریشه استخوانهای بینی شروع شده ودر بالا به پوست بینی دو ابرو می چسبد. انقباض این عضله موجب ایجاد یک خط عرضی بین دو ابرو می شودو شبیه حالتی که در دقت پدیدارمی گردد.این عضله توسط شاخه Buccal عصب فاسیال تغذیه می شود.

Orbicularis oris:

این عضله یک عضله مدور است که در ضخامت لبها قرار دارد. انقباض این اعضله موجب جمع شدن دهان و غنچه شدن لبها می شود. عصب آن از شاخه Buccal عصب فاسیال است.

Levator Labi superior:

این عضله از بالای سوراخ Infra orbital از لبه اربیت منشا می گیرد و در پایین به لب فوقانی خاتمه پیدا می کند. عصب آن از شاخه Buccal عصب فاسیال است.

Levator Anguli oris:

این عضله نسبت به عضله قبلی عمقی تر و از پایین سوراخ اینفرا اربیتال و برجستگی canine منشا می گیردو در پایین به گوشه لب خاتمه می یابد. عصب این عضله از شاخه Buccal عصب فاسیال است.

Levator labi superior and alaeque nasi:

این عضله از زائده Frontal استخوان ماگزیلا منشا می گیرد. در پایین بدو شاخه داخلی و خارجی تقسیم می شود. شاخه خارجی به لب بالا و شاخه داخلی به پره بینی می چسبد. عصب آن از شاخه Buccalعصب فاسیال است.

Zygomaticus major and minor

من برای خواندن دقیق و استخراج کامل متن از تصویر جدید آپلود شده(photo_1783690310606.jpeg) ، از ابزار بازیابی فایل استفاده می‌کنم تا متن آن را بدون هیچ تغییری برای شما استخراج کنم.

این عضلات در بالا از استخوان گونه منشا میگیرند و در پایین به گوشه های خاتمه می یابند. عمل این عضلات این است که گوشه دهان را به سمت بالا خارج میبرند عضله Zygomatic major از شاخه Zygomatic عصب فاسیال و Zygomatic Minor از شاخه buccal عصب فاسیال عصب می گیرد.

Depressor Anguli oris :

این عضله در پایین به قسمت خارجی خط مایل استخوان مندیبل و در بالا به گوشه دهان می چسبد. عمل عضله گوشه دهان را به سمت پایین میکشاند عصب این عضله توسط شاخه Buccal عصب فاسیال و همچنین شاخه Marginal mandibular حاشیه ای فکی عصب فاسیال عصب می گیرد.

Depressor Labi inferior :

از قسمت داخلی خط مایل شروع شده و در بالا به لب تحتانی خاتمه پیدا می کند. عصب آن از عصب MandibularMarginalعصب فاسیال است.

Mentalis :

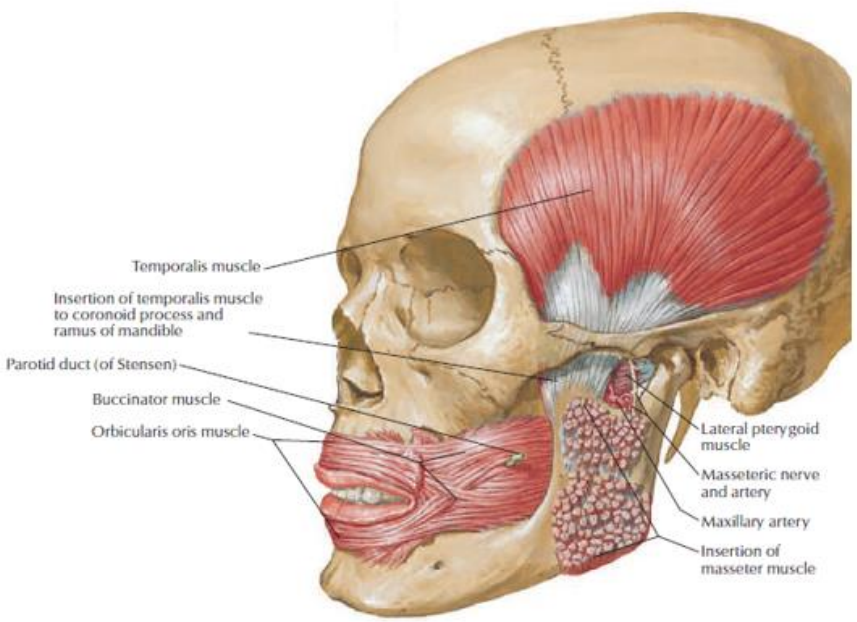
این عضله از برجستگی Incisive فک پایین شروع شده و در پایین به پوست چانه اتصال پیدا می کند .عصب آن از Marginal mandibular عصب فاسیال است.

Resorious :

این عضله از فاسیای غده پاروتید شروع شده و به سمت جلو و داخل می آید و به گوشه دهان خاتمه پیدا می کند انقباض عضله گوشه دهان را به طرفین کشیده و حالت تبسمدر انسان ایجاد می کند .

عصب از شاخه Buccal عصب فاسیال است.

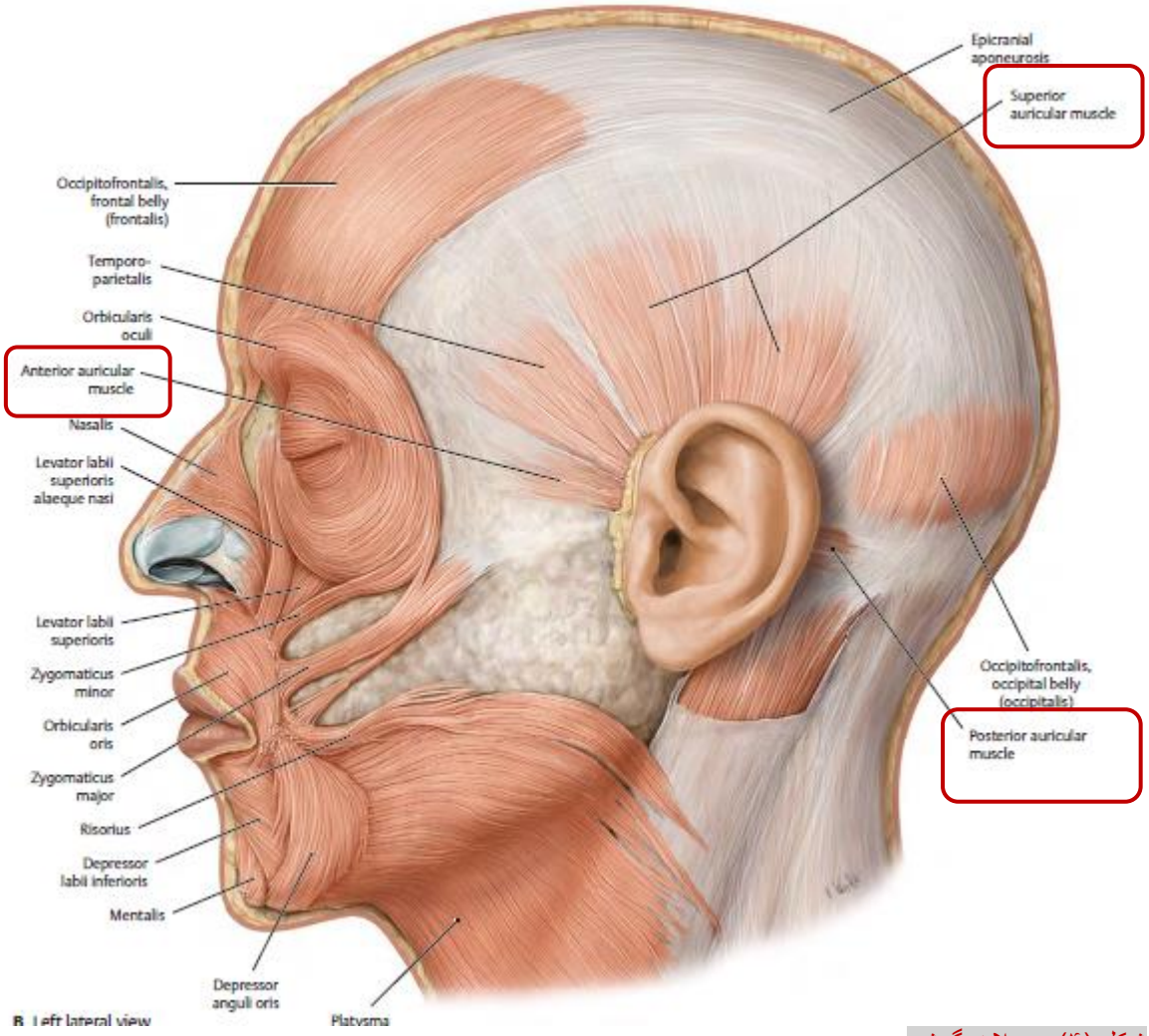
Buccintor :



شکل (۳) عضله بوکسیناتور

الیاف این عضله در بالا به سطح خارجی زائده Alveolar استخوان فک بالا و در پایین به سطح خارجي زائده Alveolar مندیبل و در عقب الیافش به رباط pterygo Mandibular اتصال می یابد. که این رباط از زائده تریگوئید تا زاویه مندیبل کشیده میشود الیاف عضلانی این عضله به سه دسته فوقانی - میانی و تحتانی تقسیم میشوند. الیاف فوقانی به لب پایین و الیاف میانی به گوشه لب و الیاف تحتانی به لب بالا خاتمه پیدا میکند عمل این عضله در سوت زدن و فوت کردن است. و در شیپور زدن این عضله قوی است. این عضله توسط مجرای غده پاروتید سوراخ می شود. عصب این عضله از شاخه buccalعصب فاسیال است .

عضلات گوشی :



شکل (۴) عضلات گوشی

علاوه بر عضلات حالت دهنده صورت عضلاتی در اطراف گوش قرار دارند که از دومین کمان حلقی مشتق می شوند و شامل سه عضله گوشی فوقانی - قدامی و خلفی است عضله گوشی فوقانی و قدامی از کلاه خود نیامی یا galea apponeurotica منشا گرفته و به قسمت جلو و بالای لاله گوش خاتمه پیدا میکند. اما عضله گوشی خلفی از زائده ماستوئید استخوان تمپورال منشا می گیرد و به قسمت خلفی لاله گوش متصل میگردد این عضلات در انسان عمل ناچیزی دارند اما در حیواناتی مثل سگ و گربه موجب تغییر جهت لاله گوش به سمت منبع صوت می شود. عضلات گوشی قدامی و فوقانی از شاخه گیجگاهی عصب فاسیال و عضله گوشی خلفی از شاخه خلفی عصب فاسیال عصب دهی می شود.

عروق صورت:

شریانهای تغذیه کننده صورت شامل:

۱ .شریان فاسیال: این شریان شریان اصلی تغذیه کننده صورت است در بالای شاخ بزرگ استخوان

هیوئید از شریان کاروتید خارجی جدا شده و از عمق غده بزاقی sub Mandibular عبور کرده و

حدود چهار سانتیمتر جلوتر از زاویه مندیبل کنار تحتانی فک را دور زده و وارد صورت می شود و بطور مایل صورت را به سمت زاویه داخلی چشم طی می کند و در زاویه داخلی چشم با شاخه های انتهایی شریان کاروتید داخلی آناستوموز پیدا می کند. این شریان در صورت در جلو ورید فاسیال قرار می گیرد. و نسبت به آن عمقی تر است. .

شاخه های شریان فاسیال:

این شاخه های بدودسته تقسیم می شوند ۱- شاخه های گردنی شامل شریانهای

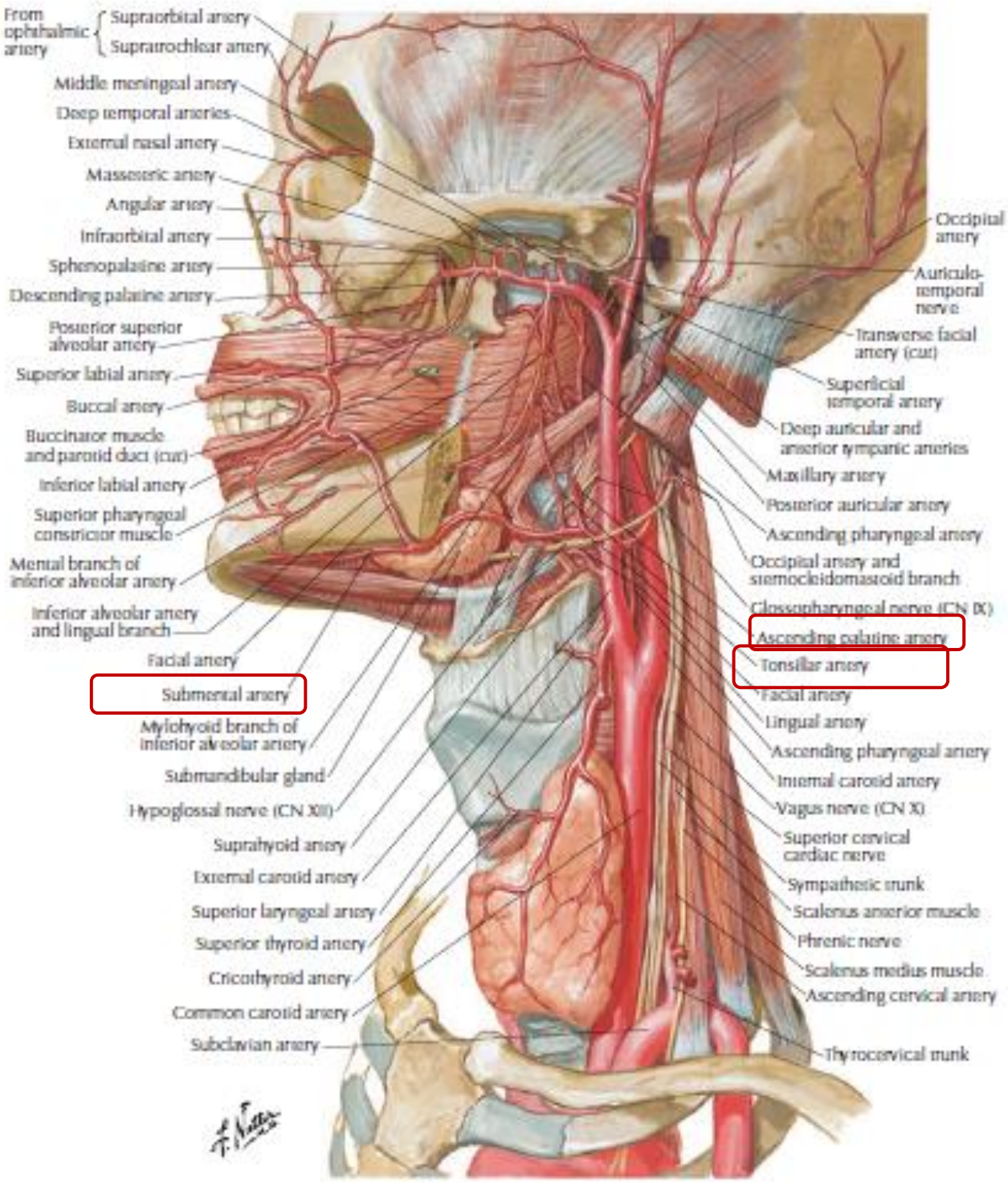
Assending palatine

Tonsilar

sub mental

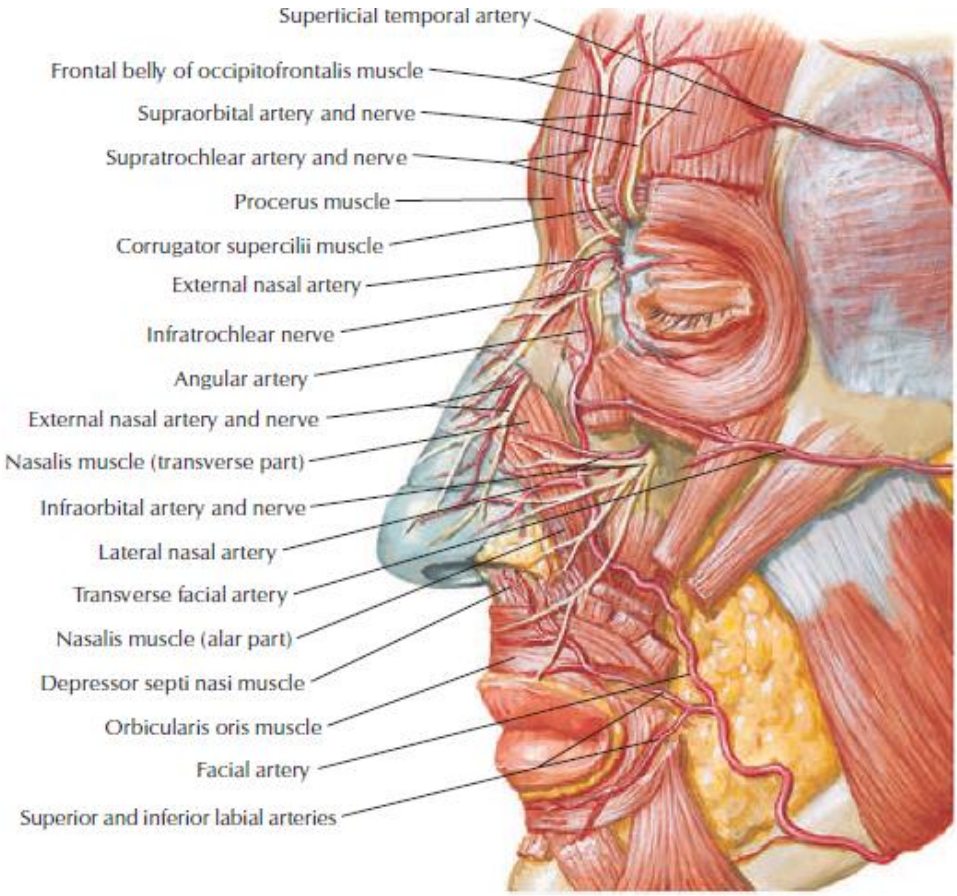
sub mandibular

می باشند



شکل (۶) شاخه های گردنی ی عروق صورت

۲ -شاخه صورتی شامل شریانهای



شکل (۶) شاخه های صورتی عروق صورت

Lateral nasal

Angular

Inferoir labial

superior labial

می باشند

شریان inferior labial این شریان پس از جدا شدن از شریان فاسیال در زیر مخاط لب تحتانی قرار می گیرد و با شریان لبی تحتانی سمت مقابل آناستوموز می دهد. این شریان نسبت به عضله مدور دهان عمقی تر است و لب پائین را تغذیه می کند .

شریان superiorlabial پس از جدا شدن از شریان فاسیال در زیر مخاط لب فوقانی قرار می گیرد و نسبت به عضله مدور دهان عمقی تر است. این شریان باشریان لبی فوقانی سمت مقابل آناستوموز می دهد و لب بالا را تغذیه می کند .

شریانهای Lateral nasal این شاخه های در شیار بین بینی و گونه از شریان فاسیال جدا شده و قسمتهای خارجی بینی را تغذیه می کنند و با شریان dorsal nasal شاخه شریان ophthalmic پیوند می شوند .

Angular branchاین شریان شاخه انتهایی شریان فاسیال است که در گوشه داخلی چشم قرار می گیرد و با شاخه های شریان کاروتید داخلی پیوند می شود.

۲) **شریان گیجگاهی سطحی**: یکی از شاخه های انتهایی شریان کاروتید خارجی است که در داخل غده پاروتید در مجاذات کنار خلفی گردن مندیبل جدا می شود. این شریان از جلوی لاله گوش عبور کرده و وارد ناحیه اسکالپ می شود. شاخه های این شریان عبارتند از :شکل (۶)

(a)شریان عرضی صورتی یا : Trans verse facial .a این شریان بصورت عرضی و در زیر قوس گونه به سمت جلو می آید و با شریان Infra orbital شاخه شریان Mxillary و شاخه های شریان فاسیال آناستوموز می دهد .

(b)شریان گوشی قدامی یا : Anterior Auricular .a این شریان قسمت جلو لاله گوش را تغذیه می کند .

(c)شریان گونه ای – کاسه چشمی Zygomatico orbital.a این شریان بطور مایل از روی

استخوان گونه عبور کرده و متوجه اربیت می گردد و عناصر اطراف استخوان گونه را تغذیه می کند .

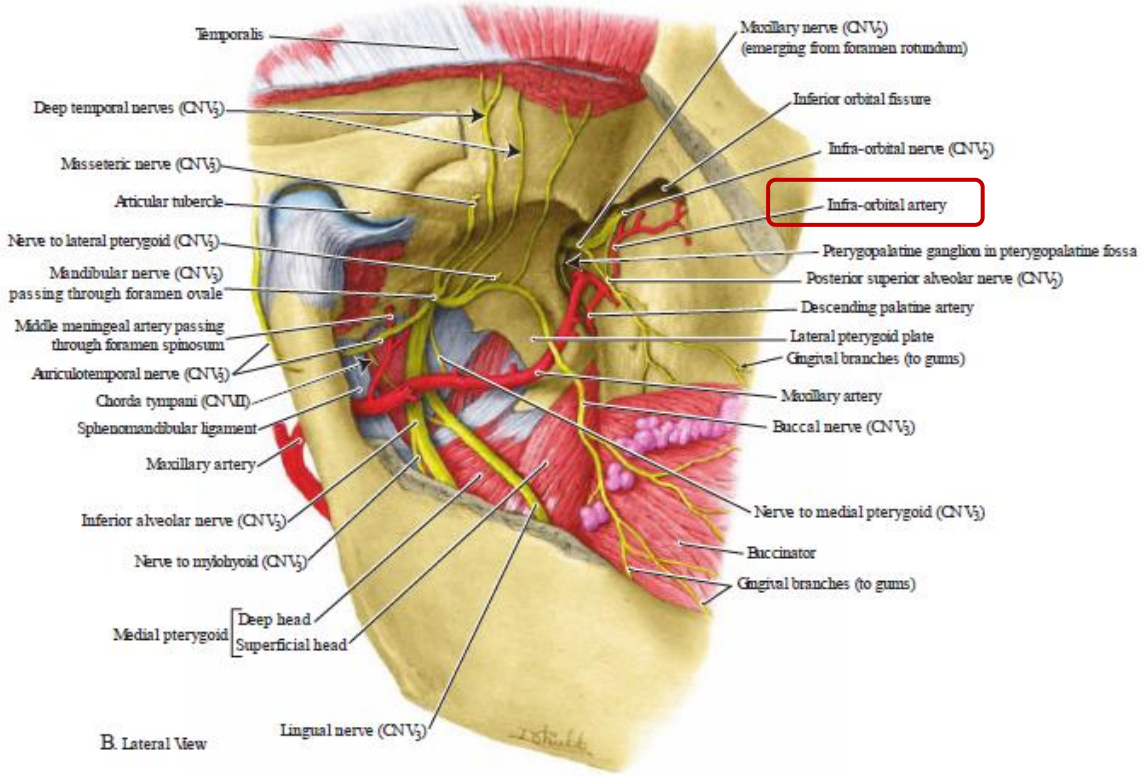
(d)شریان تمپورال عمقی میانی یا deep middle temporal .a شاخه ایست که پس از جدا شدن از شریان گیجگاهی سطحی عضله temporalis را سوراخ می کند و در قسمت عمقی عضله با شریانهای گیجگاهی عمقی قدامی و خلفی شاخه های شریان ماگزیلاری آناستوموز پیدا می کند .

(e)شریان پیشانی یا frontal.a

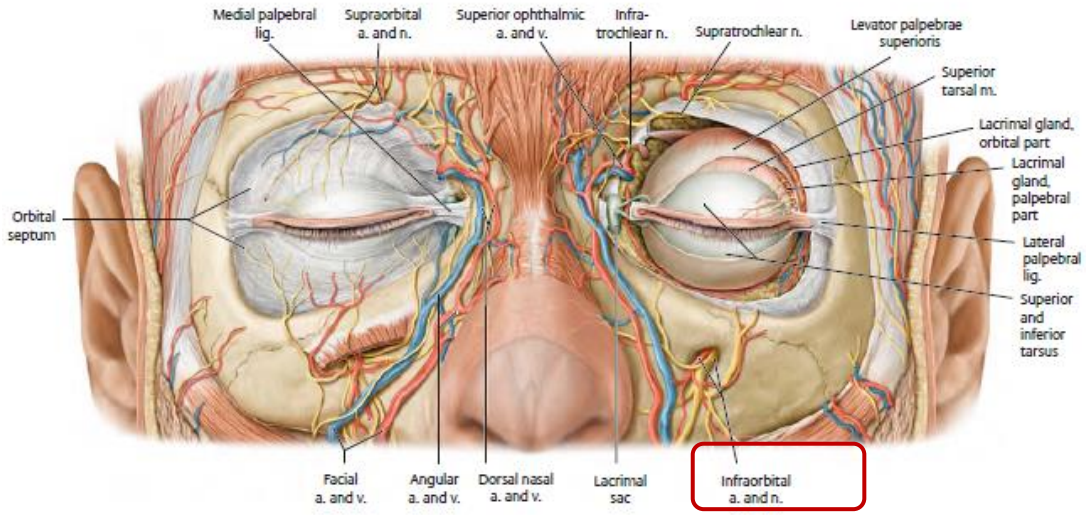
(t)شریان آهیانه یا .aparietal

دو شاخه بعدی شریان گیجگاهی سطحی شاخه فرونتال وپاریتال وارد ناحیه اسکالپ شده و قسمتهای طرفی اسکالپ را تا درز ساجتیال فوقانی تغذیه می کنند.نبض شریان گیجگاهی سطحی بلافاصله در جلو لاله گوش قابل لمس است .

Infra orbital (3)



شکل (۷) شریان اینفرا اربیتال



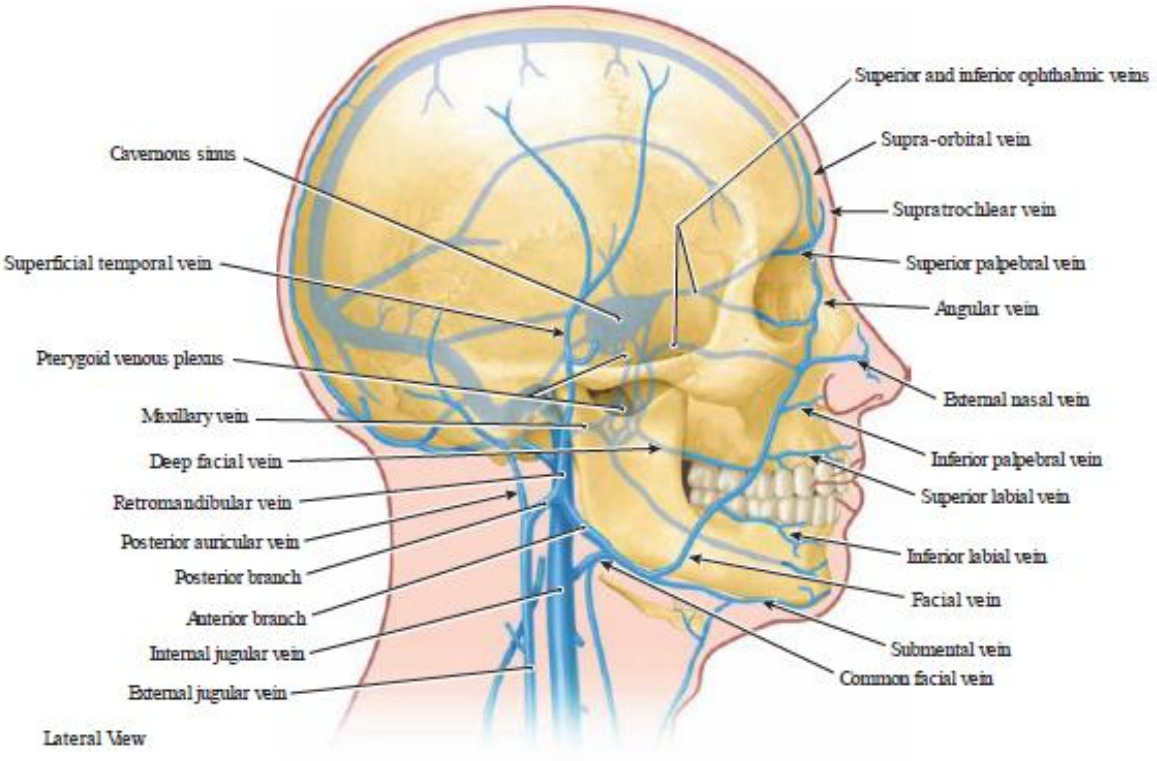
شکل (۸) شریان اینفرا اربیتال در صورت

شاخه ایست که از سومین قسمت شریان ماگزیلاری جدا می شود شکل (۷)از طریق شکاف کاسه چشمی تحتانی همراه با عصبInfra onbital وارد اربیت شده و پس از طریق ناودان – مجرا و سوراخinfra orbital عبور کرده و وارد صورت می شود. شاخه های این شریان در پلک تحتانی، ناحیه گونه خارج بینی ولب فوقانی بخش می گردد شکل (۸)

Supra orbital, supra Trochlear (4

ایندو شریان شاخه های شریان افتالمیک هستند که ازاربیت و از طریق بریدگی فوق کاسه چشمی و بریدگی فرونتال عبور کرده و وارد ناحیه پیشانی می شوند.ایندو شریان پلک فوقانی و ناحیه قدامی اسکالپ تاvertex جمجمه را تغذیه می کند. شکل (۸).

وریدهای صورت:



شکل (۹) وریدهای صورت

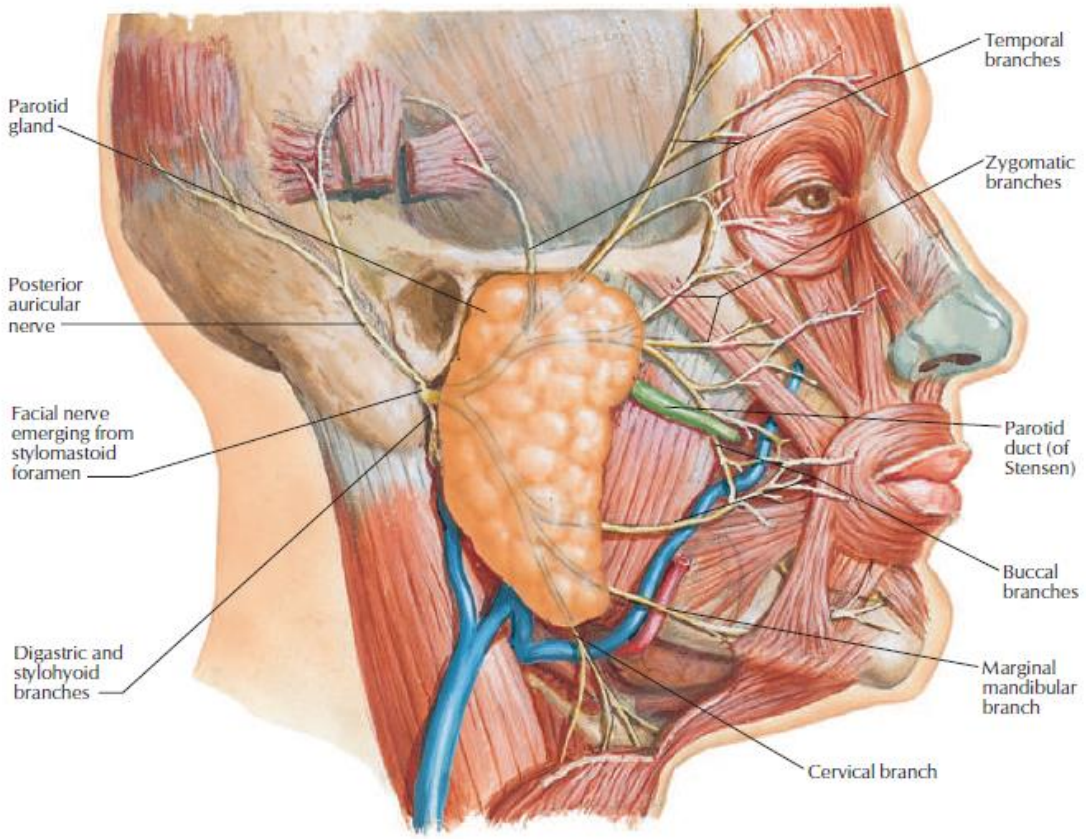
ورید های صورت شامل ورید فاسیال و ورید گیجگاهی سطحی است.

۱-<u>ورید فاسیال:</u> درگوشه داخلی چشم وریدفاسیال از بهم پیوستن وریدهای supra Trochlear, supra orbitalوورید Angulur تشکیل و در شیار بین بینی و گونه به سمت پایین می آیدو ورید های خارجی بینی- ورید لبی فوقانی و تحتانی را در یافت می کند. در صورت ورید فاسیال نسبت به شریان فاسیال عقب تروسطحی تر است. ورید فاسیال پس از وارد شدن به گردن با شاخه قدامی ورید رترومندیبولار ورید common facial را تشکیل می دهند که این ورید به ورید ژوگولار داخلی تخلیه می شود.

۲-<u>ورید گیجگاهی سطحی</u>: این ورید تمام ورید های همراه شاخه های شریان گیجگاهی سطحی را دریافت می کند و در داخل غده پاروتید به ورید ماگزیلاری متصل شده و تشکیل ورید رترو مندیبولار را می دهد. ورید رترو مندیبولار در عقب گردن مندیبل بدوشاخه خلفی وقدامی تقسیم می شود .

شاخه خلفی آن به ورید گوشی خلفی متصل شده و ورید ژوگولار خارجی را تشکیل و شاخه قدامی آن به ورید فاسیال ملحق شده وورید فاسیال مشترک را می سازد که نهایتا به ورید ژوگولار داخلی می ریزد.

- اعصاب ناحیه صورت:



شکل (۱۰) اعصاب صورت

عصب حرکتی ناحیه صورت عصب فاسیال و عصب حسی آن سه شاخه عصب سه قلو یا Trigeminal می باشد

۱ -عصب فاسیال :شکل (۱۰)

این عصب دارای دوریشه حسی و حرکتی می باشد. شاخه حرکتی آن از هسته حرکتی زوج ۷ مشتق و نهایتا به عضلات حالت دهنده صورت عصب می دهد. اما شاخه حسی آن، حس چشایی ۲/۳ قدامی زبان را به هسته solitary منتقل می کند. قسمت حرکتی آن همچنین حاوی رشته های پاراسمپاتیک است که برخی از این رشته های پاراسمپاتیک از هسته

بزاقی فوقانی منشا وموجب ترشح غده بزاقی تحت فکی و زیرزبانی میگردد وبزخی دیگر از رشته های پاراسمپاتیک از هسته Lacrimomuconasal منشا می گیرند. که نهایتا موجب ترشح غدد مخاطی ناحیه بینی کام نرم و غده اشکی می گردد. دو ریشه عصب زوج هفت بهم دیگر متصل شده و وارد مجرای گوش درونی می گردد و در عمق مجرای گوش داخلی ایجاد گانگلیونی بنام geniculate یا زانویی می کند سپس عصب وارد استخوان پتروز تمپورال شده و با یک مسیر افقی در زیر مخاط جدار داخلی صندوق صماخ و یک مسیرعمودی درضخامت جدار خلفی صندوق صماخ طی مسیر کرده و نهایتا از سوراخ stylomastoid از جمجمه خارج میگردد و وارد غده پاروتید می شود

در درون غده پاروتید عصب بدوتنه گیجگاهی - صورتی tempro facial و گردنی - صورتی cervico facial تقسیم می شود که هریک از این تنه ها به سه شاخه تقسیم می گردند.

شاخه های تنه گیجگاهی- صورتی عبارتند از:

(a)شاخه تمپورال (b) شاخه گونه ای (C) شاخه بوکال فوقانی

شاخه های تنه گردنی- صورتی عبارتند از:

a) بوکال تحتانی b) مارجینال مندیبولار c) شاخه سرویکال

شاخه های عصب فاسیال:

به دو دسته داخل استخوانی و خارج استخوانی تقسیم می شوند:

۱ -شاخه های داخل استخوانی چهار شاخه اند:

(a) grater petrosal nerve یا عصب خاره ای بزرگتر: این عصب از گانگلیون زانویی جدا شده پس از عبور هیاتوس فالوپ وارد سطح قدامی پتروز می شود و در شیار مخصوص خود حرکت می کند. از طریق سوراخ lacerum از جمجمه خارج می گردد. سپس به عصب deep petrosal متصل شده و عصب canal vidian را تشکیل می دهد و این عصب از طریق کانال vidian یا مجرای تریگوئید عبور کرده وارد حفره تریگو پالاتین می شود و در گانگلیون تریگوپالاتین سیناپس می کند. و رشته های پس عقده ای آن از طریق شاخه های عصب Maxillary نهایتا موجب ترشح غده مخاطی کام نرم و حفره بینی و غده اشک می گردد.

(b) Geniculo tympanic:این عصب به شاخه تیمپانیک زوج ۹ متصل شده و عصبlesser petrosal را تشکیل می دهد. عصب lesser petrosal از طریق هیاتوس فالوپ فرعی وارد سطح قدامی پتروز شده و پس از عبور از سوراخ بیضی در گانگلیون otic سیناپس می کند. رشته های پس عقده ای این عصب همراه عصب گوشی گیجگاهی یا Auriculo Temporalکه شاخه ای از تنه خلفی عصب مندیبولار است وارد غده پاروتید شده و موجب ترشح این غده می شود.

(C) عصب برای عضله رکابی(Nerve to stapedius muscle) :

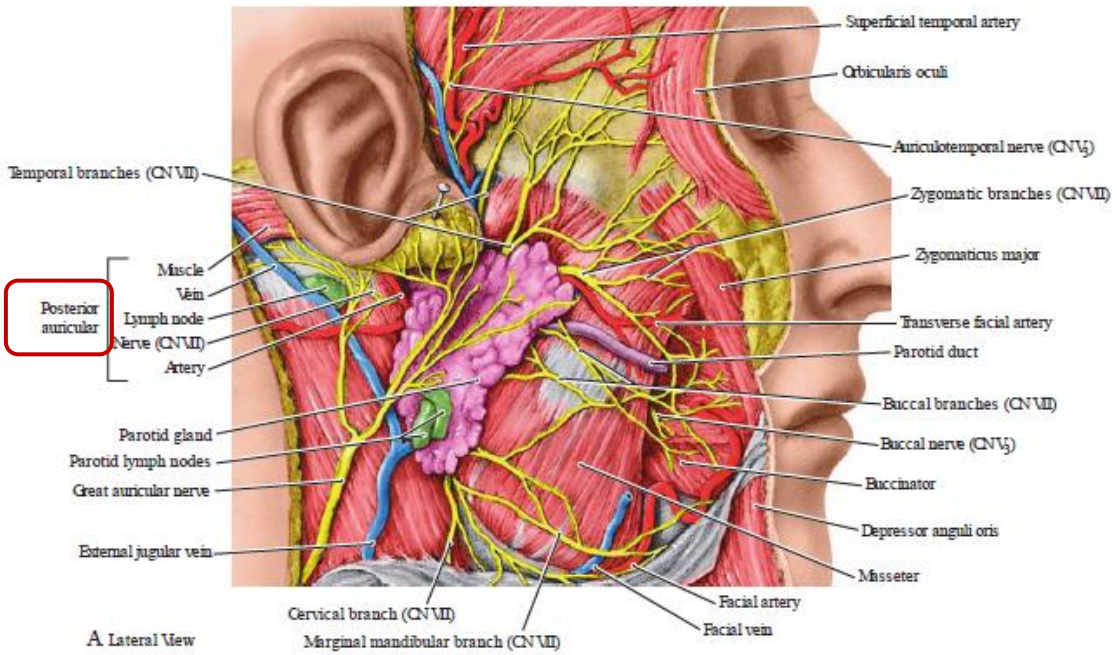
این عصب زمانیکه عصب فاسیال در جدار خلفی صندوق صماخ قرار گرفته از عصب فاسیال جدا می گردد و از کانال مخصوص عضله رکابی که در جدار خلفی صندوق صماخ است به عضله رکابی رسیده و این عضله را عصب می دهد.

(d)عصب طناب صماخی یا chorda tympani: این عصب پنج میلیمتر بالاتر از سوراخ stylomastoid از عصب فاسیال جدا شده وارد کانال مخصوص خود در جدار خلفی صندوق صماخ می شود. این عصب از مرز بین جدار خارجی و جدار خلفی صندوق صماخ وارد صندوق صماخ شده و در زیر مخاط جدار خارجی صندوق صماخ و در بالای پرده صماخ و در سمت داخل دسته استخوان چکشی به سمت جلو حرکت کرده و از شیار پتروتیمپانیک از صندوق صماخ خارج می شود. این عصب دارای دو نوع رشته است یکسری از رشته هایش رشته های پیش عقده ای پاراسمپاتیک است که پس از سیناپس در گانگلیون ساب مندیبولارموجب تر شح غددبزاقی تحت فکی وزیر زبانی می

گرددویکسری از رشته هایش مربوط به حس چشایی ۳/۲ قدامی می باشد.

اگر این عصب قطع گردد موجب اختلال ترشح غدد بزاقی Sub mandibular و sub lingual و موجب از بین رفتن حس چشایی ۲/۳ قدامی زبان می شود.

۲) شاخه های خارج استخوانی شامل چهار شاخه اند:



شکل (۱۱) شاخه های خارج استخوانی عصب فاسیال

الف) Posterior Auricular nerveیا عصب گوشی خلفی به بطن پس سری عضله پیشانی پس سری و عضله گوشی خلفی عصب می دهد.

ب)-عصب بطن خلفی دیگاستریک و استیلوهیوئید پایین تر از شاخ قبلی جدا شده و بطن خلفی

عضلات دیگاستریک و استیلوهیوئید را عصب می دهد.

ج) تنه :Temprofacial این تنه به سه شاخه گیجگاهی، گونه ای و شاخه بوکال فوقانی تقسیم می

شود شاخه گیجگاهی آن به عضلات گوشی قدامی – گوشی فوقانی - مدور چشم- بطن پیشانی عضله پیشانی- پس سری و عضله چین دهنده ابرو عصب می دهد.

شاخه zygomatic این شاخه به عضلات گونه ای بزرگ و عضله مدور چشم عصب می دهد.

شاخه بوکال فوقانی : با عصب بوکال تحتانی تنه گردنی صورتی با هم عصب بوکال را ایجاد می کنند که این عصب به عضلات گونه ای کوچک - بالا برنده لب بالا - بالا برنده گوشه دهان - بالابرنده لب بالا و پره بینی - عضله هرمی - عضله مدور دهان - عضله شیپوری - عضله خندان - عضله بینی -عضله پائین آورنده سپتوم بینی وعضله پائین آورنده گوشه دهان عصب می دهد.

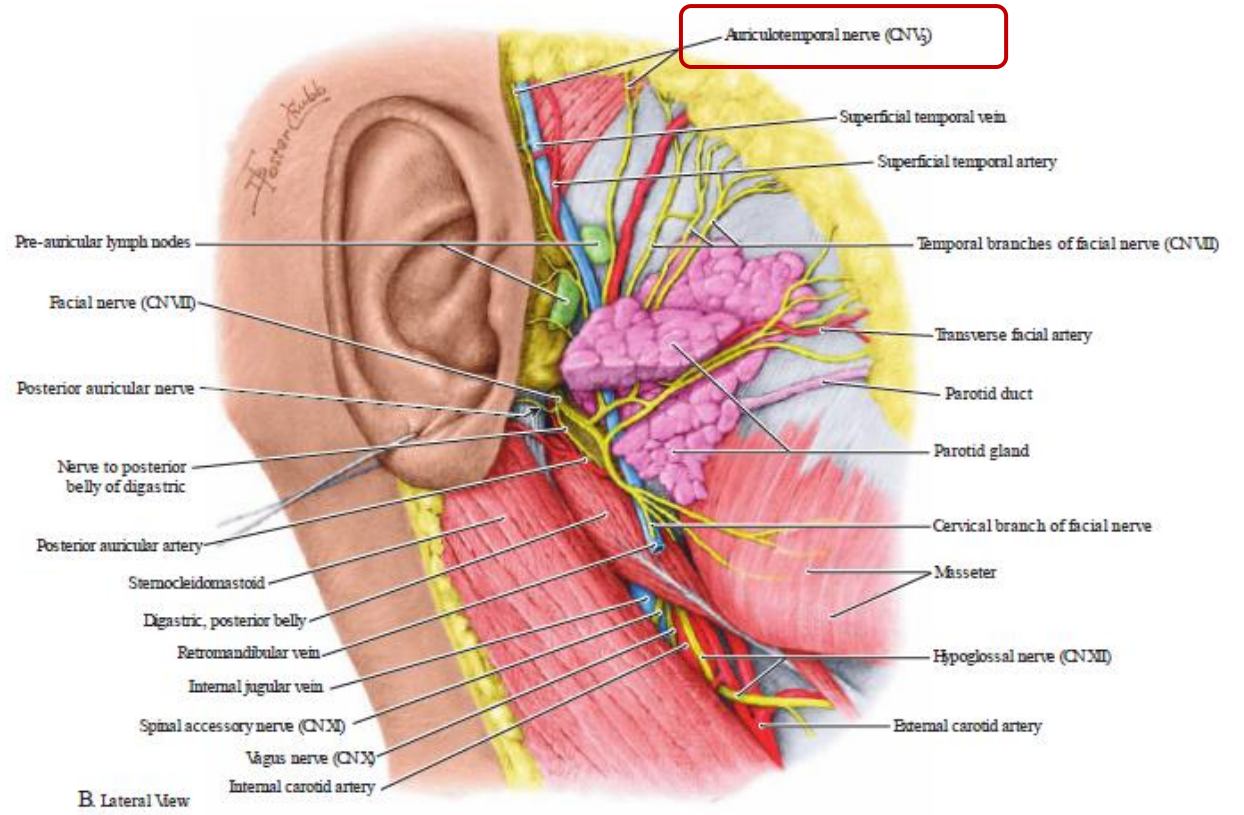
تنه-سرویکوفاسیال Cervico facial

به سه شاخه عصبی بوکال تحتانی- مارجینال مندیبولار وسرویکال تقسیم می شود.عصب حاشیه فکی در حاشیه فک در زیر عضله پلاتیسما حرکت می کند و به عضلات پائین آورنده لب پائین و چانه ای

عصب می دهد. شاخه گردنی عصب فاسیال پس از عبور از عقب زاویه مندیبل وارد گردن شده و به

عضله پلاتیسما عصب می دهد.

اعصاب حسی صورت:



شکل (۱۲) اعصاب حسی و حرکتی صورت

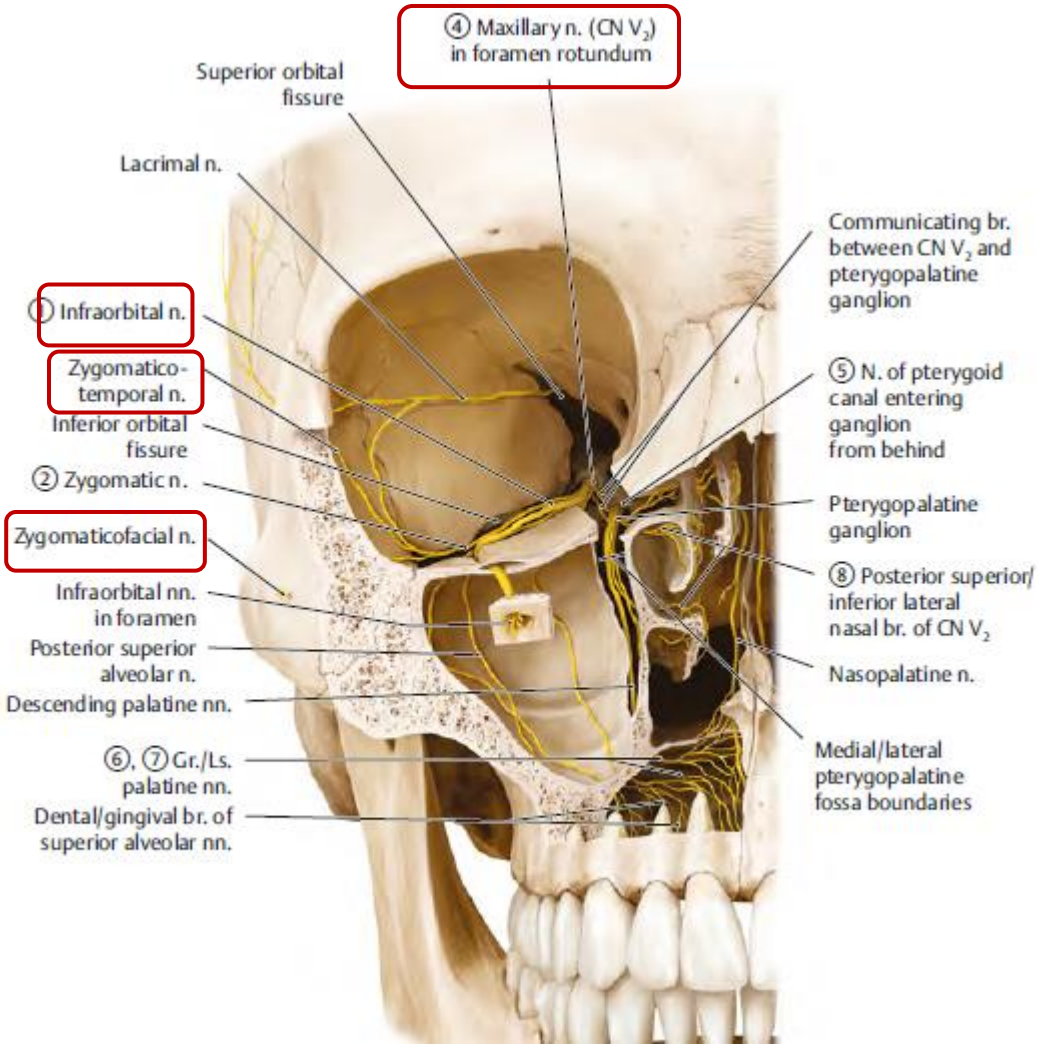
حس صورت توسط سه شاخه عصب سه قلو تأمین می شودو شاخه های آن عبارتند از:

1) شاخه :ophthalmic این عصب توسط چهارشاخه خود که شامل اعصاب سوپرا ترکلئاروسوپرا اربیتال شکل (۸)حس ناحیه پیشانی وپلک فوقانی وعصب اینفرا تروکلئار حس گوشه داخلی چشم – قسمت داخلی پلکها و حس کیسه اشک و عصب نازوفرونتال حس ریشه بینی -پشت بینی تا نوک بینی را تأمین می کند.

2) شاخه :Maxillary شاخه دوم عصب زوج ۵ توسط شاخه هایzygomaticatemporal و zygomaticafacialو Infra orbital به ترتیب حس قسمت قدامی ناحیه گیجگاهی - حس ناحیه گونه - حس پلک تحتانی و حس صورت پایین شکاف پلکی تا شکاف دهانی وحس پره های بینی را تأمین می کند.

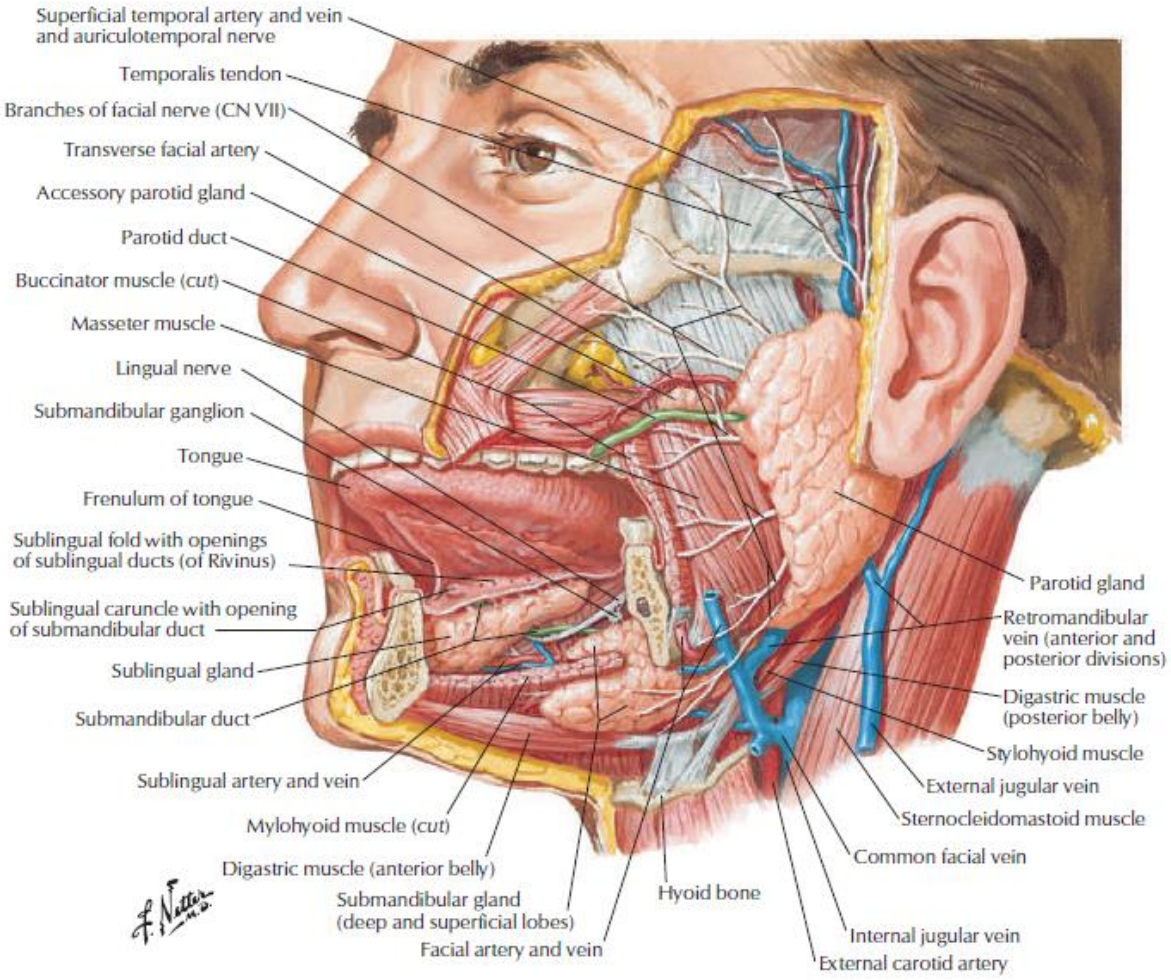
3) عصب : Mandibular توسط **شاخه های Auriculotemporal** حس ناحیه گیجگاهی به جز ناحیه قدامی و inferior alveolar حس آرواره پایین و لب تحتانی وبوکال حس قسمتی از ناحیه گونه را تأمین می کند.

نکته:عصب بوکال مندیبولار حسی ولی عصب بوکال فاسیال حرکتی است.



شکل (۱۳) عصاب حسی صورت

ناحیه پاروتید:



شکل (۱۴) ناحیه و غده پاروتید

ناحیه ایست در صورت که جایگاه قرارگیری غده بزاقی پاروتید است. محدوده پاروتید شامل:

محدوده فوقانی آن external acoustic meatus (سوراخ گوش بیرونی) و مفصل T.M.j و محدوده تحتانی آن زاویه مندیبل و محدوده خلفی آن کنار قدامی عضله استر نوکلئیدو ماستوئید و بطن خلفی دیگاستریک و محدوده قدامی آن عضله Masseteric - راموس مندیبل و عضله تریگوئید داخلی می باشد.

غده پاروتید:

این غده توسط لایه سطحی و عمقی فاسیای Investing غلاف شده و مجاورت خارجی آن با فاسیای و پوست صورت است.

مجاورت سطحی داخلی آن با غلاف کاروتید و با واسطه فضای طرفی حلق با عضله تنگ کننده فوقانی حلق است. در ضخامت غده سه عنصر عصب فاسیال-ورید رترو مندیبولاروشریان کاروتید بیرونی ازسطح به عمق عبور می کنند شکل (۱۴).